

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

EVALUACIÓN COMUNITARIA DE EXPERIENCIAS PSÍQUICAS (CAPE-42)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Cribado Fenotípico de Síntomas Positivos, Negativos y Depresivos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Evaluación Comunitaria de Experiencias Psíquicas (CAPE-42).
Nombre Original (Inglés)	<i>Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE)</i> .
Autores del Diseño Original	Drs. N. C. Stefanis, M. Hanssen, N. K. Smirnis, D. A. Avramopoulos, I. K. Evdokimidis, C. N. Stefanis, H. Verdoux y J. Van Os (2002), Universidades de Atenas, Burdeos y Maastricht.
Adaptación al Español	Dr. Eduardo Fonseca-Pedrero, M. Paino, S. Lemos-Giráldez, J. Muñiz et al. (2013).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Detección temprana en salud mental comunitaria y estados de riesgo.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme clínico y comunitario con doble escala de valoración (Frecuencia y Distrés).
Población Diana y Rango	Adolescentes y adultos (14 a 65 años) en población general, atención primaria o salud mental ambulatoria.
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos en autoaplicación guiada.
Régimen de Licencia	Dominio público científico sin fines comerciales. Libre reproducción con citación obligatoria de autores.

2. MARCO TEÓRICO: EL MODELO DIMENSIONAL DEL CONTINUUM PSICÓTICO

El CAPE-42 fue desarrollado para superar la visión categorial clásica de la psicosis, fundamentándose en el **paradigma del continuum fenotípico** (Van Os et al., 2000, 2009). Desde esta perspectiva, las experiencias de tipo psicótico (alucinaciones auditivas tenues, suspicacia persecutoria o vivencias de referencia) no son exclusivas de trastornos clínicos estructurados, sino que se distribuyen en gradiente a lo largo de la población general.

La transición de una vivencia subclínica benigna hacia un estado clínico con necesidad de atención médica depende críticamente de tres factores moderadores: **(a) la persistencia temporal** de la experiencia, **(b) el grado de angustia o distrés subjetivo** asociado, y **(c) la alteración funcional secundaria** en roles sociolaborales. Por ello, el CAPE introduce de forma pionera la **doble escala simultánea**: medir no solo si el fenómeno ocurre, sino el impacto emocional que provoca.

3. DIMENSIONES EVALUADAS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión	N.º Ítems	Contenido Fenomenológico e Ítems Constituyentes
1. Sintomatología Positiva	20 ítems	Explora delirios de persecución, ideas de referencia, grandiosidad, fenómenos de pasividad y alucinaciones perceptivas auditivas y visuales. Ítems: 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 41 y 42 . (Basados en el PDI-21 de Peters et al.).
2. Sintomatología Negativa	14 ítems	Evalúa dimensiones deficitarias: embotamiento afectivo, alogia, anhedonia física/social, abulia, amotivación y desatención del autocuidado. Ítems: 3, 4, 8, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 35, 36 y 37 . (Derivados de la escala SENS).
3. Sintomatología Depresiva	8 ítems	Distingue la sintomatología negativa del componente afectivo nuclear: desesperanza, tristeza profunda, culpa, anhedonia reactiva y vulnerabilidad autolítica. Ítems: 1, 9, 12, 14, 19, 38, 39 y 40 .

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS

Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) corrobora de forma consistente el modelo tridimensional oblicuo (Positivo, Negativo, Depresivo) tanto en cohortes generales internacionales (N > 3000) como en la validación española (CFI = 0.94, RMSEA = 0.046).
Consistencia Interna (Alfa)	Excelente confiabilidad global y factorial: Dimensión Positiva (alfa = 0.82 - 0.88), Dimensión Negativa (alfa = 0.78 - 0.85), Dimensión Depresiva (alfa = 0.75 - 0.82), Escala Total (alfa = 0.92).
Validez Concurrente	Correlaciones elevadas y estadísticamente significativas con el PDI-21 (r = 0.76), BPRS (r = 0.65), SANS (r = 0.68) y escalas de depresión de Beck (r = 0.71).
Estabilidad Temporal	Excelente fiabilidad test-retest a 6 meses (r = 0.78 - 0.84), confirmando su idoneidad para monitoreo longitudinal de trayectorias clínicas.

5. ALGORITMO Y REGLAS DE CALIFICACIÓN

El protocolo califica cada ítem en dos escalas Likert de 4 puntos:

- Escala de Frecuencia:** 1 = Nunca, 2 = A veces, 3 = Con frecuencia, 4 = Casi siempre.
- Escala de Distrés:** 1 = Ningún malestar, 2 = Ligero malestar, 3 = Bastante malestar, 4 = Mucho malestar (solo si frecuencia >= 2).

FÓRMULA DE PUNTUACIONES MEDIAS PONDERADAS (CONTROL DE OMISIONES):

Para neutralizar el efecto de ítems omitidos y unificar la interpretación en un rango directo de 1.00 a 4.00:

$$\text{Puntuación Media Factorial} = (\text{Suma de puntuaciones directas}) / (\text{N.º de ítems respondidos en la dimensión})$$

Se obtienen 6 índices principales: Media Frecuencia Positiva, Media Distrés Positivo, Media Frecuencia Negativa, Media Distrés Negativo, Media Frecuencia Depresiva, Media Distrés Depresivo, más los totales globales.

6. BAREMOS CLÍNICOS Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

Nivel de Riesgo	Media Frecuencia	Media Distrés	Significación Clínica y Conducta Asistencial
1. Bajo / Normativo	1.00 a 1.35	1.00 a 1.20	Población general asintomática. Ausencia de vivencias anómalas o fenómenos aislados sin perturbación afectiva.
2. Vulnerabilidad Leve	1.36 a 1.50	1.21 a 1.70	Vivencias inusuales infrecuentes. Requiere seguimiento expectante si coexisten antecedentes familiares o consumo de cannabis.
3. Estado de Riesgo Mental (ARMS)	>= 1.50 (Positiva)	>= 1.80 (Positiva)	Síntomas psicóticos atenuados (APS) con sufrimiento subjetivo. Criterio de inclusión para unidades de intervención temprana en psicosis.
4. Crisis / Episodio Agudo	>= 2.20 (Positiva)	>= 2.50 (Positiva)	Alta frecuencia y disrupción. Sospecha fundada de episodio psicótico franco o crisis depresiva severa. Derivación urgente.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DETECCIÓN PRECOZ (ESTADO MENTAL DE ALTO RIESGO - ARMS)

PROTOCOLO SECUENCIAL DE ATENCIÓN EN INTERVENCIÓN TEMPRANA:

1. **Paso 1 (Cribado Universal/Selectivo):** Administrar CAPE-42 a consultantes jóvenes (15-30 años) con caída de rendimiento, aislamiento o labilidad afectiva. 2. **Paso 2 (Análisis del Patrón):** Si Dimensión Positiva Media ≥ 1.50 con distrés moderado (≥ 1.80): No alarmar al paciente; descartar consumo reciente de tóxicos (cannabis, psicoestimulantes). 3. **Paso 3 (Entrevista Estructurada):** Administrar entrevista especializada (CAARMS o SIPS) para graduar los síntomas atenuados o breves intermitentes. 4. **Paso 4 (Abordaje Terapéutico):** Psicoeducación libre de estigma, TCC centrada en la reducción del distrés y regulación del sueño/estrés sin prescripción inmediata de antipsicóticos salvo descompensación manifiesta.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERPRETACIÓN EN ATENCIÓN AMBULATORIA

Paciente: Varón de 20 años, estudiante de informática, remitido por la enfermera universitaria debido a pérdida progresiva de concentración, apatía y quejas de que "sus compañeros de residencia le lanzan indirectas malintencionadas y nota el ambiente enrarecido". **Puntuaciones CAPE-42:** • **Dimensión Positiva:** Frecuencia Media = **1.85** (elevada); Distrés Medio = **2.60** (bastante malestar). Ítems destacados: ítem 2 (indirectas, frec: 3, distrés: 3), ítem 6 (gente no es lo que parece, frec: 3, distrés: 3), ítem 30 (eco del pensamiento, frec: 2, distrés: 3). • **Dimensión Negativa:** Frecuencia Media = **2.15**; Distrés Medio = **1.75**. Marcada falta de motivación y aislamiento social. • **Dimensión Depresiva:** Frecuencia Media = **1.40**; Distrés Medio = **1.30** (sin ideación autolítica en ítem 14). **Juicio Diagnóstico y Plan:** Estado Mental de Alto Riesgo de Psicosis (ARMS / At-Risk Mental State), subtipo Síntomas Psicóticos Atenuados (APS). Se descarta consumo de cannabis con analítica tóxica negativa. Se inicia intervención psicológica cognitivo-conductual orientada a contrastar hipótesis delirantes suaves, higiene de sueño y desescalada de estrés académico, evitando antipsicóticos en fase inicial y con seguimiento semanal estrecho. A las 8 semanas, el distrés positivo desciende a 1.40.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y PAUTAS DEONTOLÓGICAS

ALERTA CRÍTICA: ÍTEM 14

Cualquier puntuación mayor a 1 en el ítem 14 ("ganas de no seguir viviendo") exige evaluación clínica inmediata del riesgo suicida y formalización de plan de seguridad.

NO PATOLOGIZAR EXPERIENCIAS

Las vivencias inusuales (como la telepatía o el déjà vu) carecen de significado patológico si no generan angustia, rigidez conviccional ni interferencia funcional.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Stefanis, N. C., Hanssen, M., Smirnis, N. K., Avramopoulos, D. A., Evdokimidis, I. K., Stefanis, C. N., Verdoux, H., & Van Os, J. (2002). Evidence that three dimensions of psychosis have a distribution in the general population. *Psychological Medicine*, 32(2), 347–358.
2. Fonseca-Pedrero, E., Paino, M., Lemos-Giráldez, S., Sierra, J., Campillo-Álvarez, A., Ordóñez-Pérez, P., & Muñiz, J. (2013). Validación de la versión española del Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE-42). *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 6(3), 115–124.
3. Van Os, J., Linscott, R. J., Myin-Germeys, I., Delespaul, P., & Krabbendam, L. (2009). A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum. *Psychological Medicine*, 39(2), 179–195.
4. Mossaheb, N., Becker, J., Schaefer, M. R., Klier, C. M., Schloegelhofer, M., Papageorgiou, K., & Amminger, G. P. (2012). The Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE) in individuals at ultra-high risk for psychosis. *Schizophrenia Research*, 140(1-3), 200–205.